

LA TUBERCULOSE EXTRA6PULMONAIRE

PLAN DU COURS

I.Généralités :

II. Definition

III. PHYSIOPATHOLOGIE

IV. PRIMOINFECTION TUBERCULEUSE

V.DISTRIBUTION

VI.Diagnostic

VII.Formes cliniques

VIII. Traitement

IX. Prevention

Références bibliographiques

TUBERCULOSES EXTRA- PULMONAIRES

I. Généralités

- Paucibacillaires
- Diagnostic : stt histologique, parfois bactériologique.
- A défaut de présomption
- 10 à 30 % des cas de TBC

La tuberculose reste un problème de santé publique, aussi bien à l'échelle mondiale que nationale

Le programme nationale de la lutte anti-tuberculeuse a permis de réduire le taux de TBC surtout dans sa forme contagieuse:

Passant de plus de 70 cas/ 100 000 habitants en 1975 à 16.9 cas en 2015 (40 ans plus tard)

Néanmoins, cette recrudescence s'est accompagnée d'une augmentation des autres formes: les TEP qui occupaient moins de 18% des TBC, en 2015 elles constituaient 64.9% des TBC

II. DEFINITION

TEP: Ensemble des formes de TB situées ailleurs que dans le poumon :

- * Soit dans l'appareil respiratoire(plèvre et médiastin)
- * Soit dans d'autres appareils (extra respiratoire)

III. PHYSIOPATHOLOGIE

Les TEP sont la conséquence précoce ou tardive d'une primo-infection latente ou patente. Souvent méconnu.

IV.PRIMOINFECTION TUBERCULEUSE

- 1er contact avec le bacille
- Déposition alvéolaire de quelques bacilles = chancre d'inoculation (foyer primaire)
- Multiplication dans les macrophages alvéolaires après phagocytose puis drainage vers le ganglion hilair satellite puis dissémination (foyers IIaires)
- Mise en place d'une réponse à médiation cellulaire en 4 à 6 semaines
- L'allergie tuberculinique n'apparaît que vers le 60^{ème} jours.
- Ainsi certains organes sont atteints précocement même en période anté allergique (miliaires,méningites)
- D'autres plus tard (gg).

V.DISTRIBUTION

- Ganglions 40 à 60%
- Plèvre
- Os+ articulations
- App génital
- Sérites
- Viscères
- Peau

VI. Diagnostic (1)

- Clinique:

Absence de vaccination BCG

Contage tuberculeux

Signes généraux:

asthénie, anorexie, fébricule sueurs
nocturnes

VI. Diagnostic (2)

- Radiographie pulmonaire
calcifications de primo infection, nodules
des apex
- Biologie:
IDR à la tuberculine (papule d'induration
sup à 10mm à la 72^{ème} heure) ??, TDIG
FNS à la limite de la normale
Dosage du l' ADA (plèvre , péritoine

VI. Diagnostic (3)

- Certitude:
BK (souvent en culture) +/- histologie

VII. Formes cliniques :

A. TBC ganglionnaire

- Clinique :
 - 4 stades
(crudités, ramolissement, fistulisation, écoulements)
 - siège cervicale+++
- Certitude:
 - ponction: caséum
 - biopsie: follicule tuberculeux

B.TBC pleurale

- Clinique:
non spécifique, évolution sub aigue voir chronique
puis séquelles en l'absence de trt .
- Ponction pleurale:
liquide citrin riche en albumine et en lymphocytes.
- Certitude:
BK + dans liquide pleural en culture dans 20 à 50%
Biopsies pleurales à l'aiguilles d'Abrams 50 à 90 %

C. Méningite

- Céphalées vomissements ,sd méningé
- Ponction lombaire liquide claire,riche en albumine,pauvre en sucres,avec 20à300 elts lymphocytaires)
- Cultures du LCR positif dans 100% si ensemencement de 3 prélèvements avant traitement

D. Miliaire

- Fièvre +++
- Atteinte multifocale(méninge foie péritoine...)
- Radio+++ image micronodulaire disséminées bilatérales)
- Bilan : Fond d'Oeil, ponction lombaire, TG....

E. PERICARDITE

- Parfois associée à un EPL
- Exsudat clair
- Risque de constriction important
- Si atteinte isolée du péricarde : diagnostic est basé sur les arguments de présomption (sujet jeune, installation aigue ou subaigue sans autre cause virale, rhumatismale ou bactérienne)

Siège	présomption	Certitude		
		Cyto	histo	bact
ADP _{peripherique} - ferme - ramolie	clinque IDR+ VS<80 mm	Caseum	80%	25 %
Pleurésie	IDR+	— %	70%	20
TOA	IDR+ RX	Caseum		60 à 90 %
Rénale	Uiv IDR+	— %	—	90
Méningée	FO+cytochimie IDR+	— %	—	< 50
Génitale	IDR+ coelioscopie	—	biopsie endomètre	

VIII. TRAITEMENT

A. Médical

- Chimiothérapie anti tuberculeuse selon PNAT
- Corticoïdes 0,5 à 1 mg/kg pendant 3 semaines

Pleurésies, péricardites, méningites ADP
médiastinales avec troubles de la
ventilation

B. Traitement complémentaire

- Orthopédie
- Autres chirurgie

IX. PREVENTION

Vaccination BCG

Trt des sujets contacts

Références Bibliographiques

Références Bibliographiques

1) PNLAT en Algérie Edition 2011

2) Guide technique à l'usage des médecins responsables de la lutte antituberculeuse dans les secteurs sanitaires 1989.

Pr. Mokrane fac de medecine de Constantine